

MICOSIS SUPERFICIALES Y DERMATOFITOSIS



Atlas Clínico y Guía Definitiva de Estudio

Fundamentos Microbiológicos: Los Dermatofitos

Hongos filamentosos queratinofílicos. Invaden exclusivamente estructuras queratinizadas (piel, pelos, uñas).

Los 3 Géneros Clave (40 especies en total)

<i>Trichophyton</i>	<i>Microsporum</i>	<i>Epidermophyton</i>
Ej: <i>T. rubrum</i> , <i>T. mentagrophytes</i> , <i>T. tonsurans</i> , <i>T. concentricum</i>	Ej: <i>M. canis</i> , <i>M. gypseum</i>	Ej: <i>E. floccosum</i>



Antropofílicos



Zoofílicos



Geofílicos

Tiña de la Cabeza (Tinea Capitis): Variedades Secas

Epidemiología: 90-98% en niños (zonas rurales, contacto con animales).

Variedad Microspórica (*M. canis*)



Invasión **Ecto-Endotrix**: Pelo grisáceo, roto a milímetros.

Tríada de Saúl

1. Placas pseudoalopécicas
2. Pelos cortos/frágiles
3. Descamación

20%



BADBEAR.MED

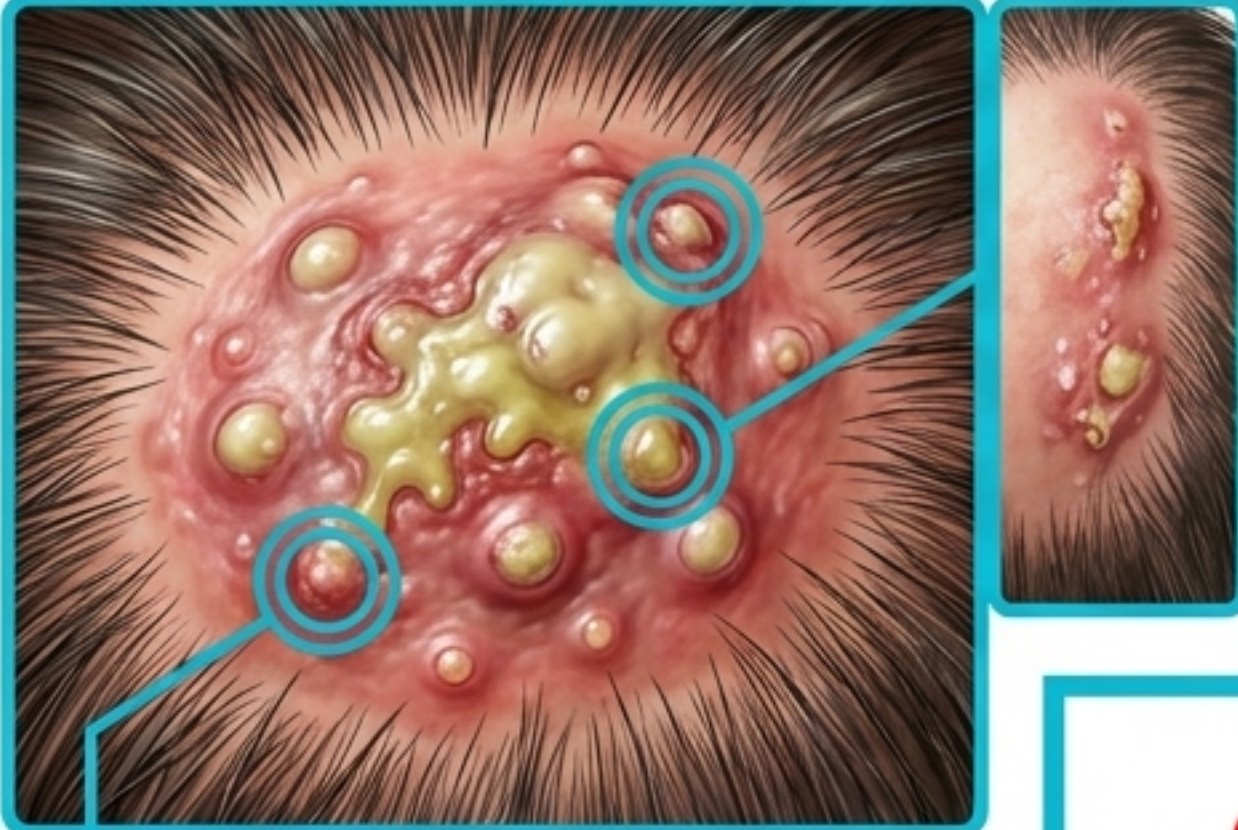
Variedad Tricofítica (*Trichophyton*)



Invasión **Endotrix** exclusiva.

Tiña de la Cabeza: Variedades Húmedas y Secuelas

Querión de Celso (Inflamatoria)

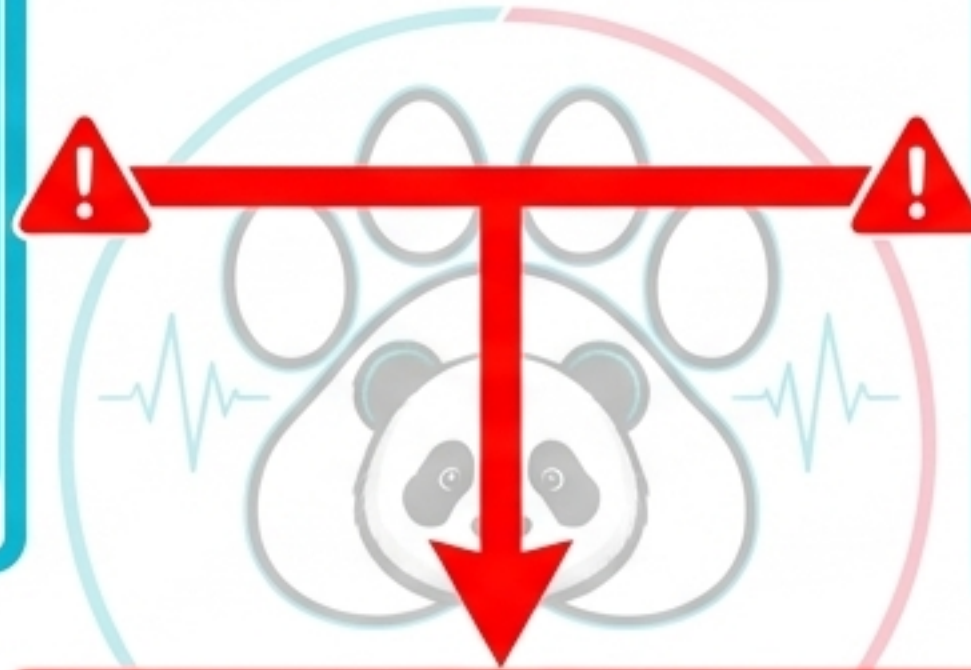


Placa única amplia, eritema, exudado purulento, costras melicéricas, abscesos, adenopatías dolorosas.

Trampa clínica: Frecuentemente mal diagnosticado como infección bacteriana.

Tiña Fávica (Favus)

Costras amarillentas (cazoletas fávicas), filamentos de queratina (panal de miel). Olor fétido (rata mojada).



Secuela Irreversible

Alopecia Cicatrizal y Fibrosis.
Daño permanente e inhabilitante al folículo piloso.



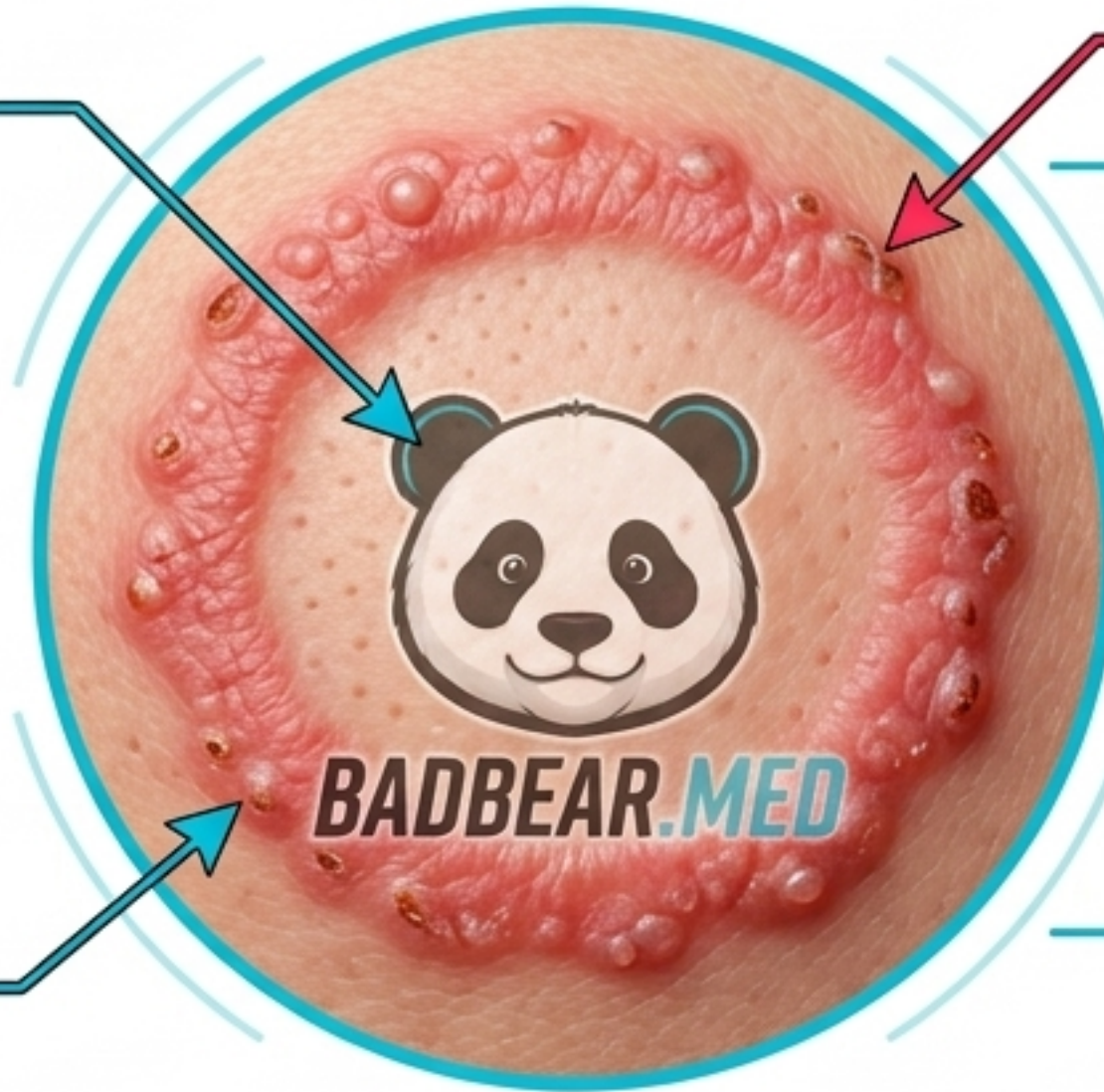
Tiña del Cuerpo (Tinea Corporis / Tiña Glabra)

Centro más claro con
tendencia a la curación.
Crecimiento centrífugo.

Borde Activo.
Eritematoso, circinado
(ondulado), elevado.

Morfología general:
Placas anulares.

Contiene vesículas,
pápulas y costras.
Prurito intenso.



Caja de Variante Rara

Tiña Imbricata (Tokelau)

Causada por *T. concentricum*.
Escamas concéntricas
adheridas que simulan un
tatuaje.



Tiña Inguinal (Tinea Cruris / Eccema Marginado de Hebra)

Perfil Clínico y Factores

Factores Predisponentes: Hombres adultos, calor, humedad, ropa ajustada, obesidad, uso previo de corticoides. (Frecuente asociación con Tinea Pedis).



Clínica: Placas eritemato-escamosas grandes, borde rojizo bronceado elevado con micropústulas (Eritema marginado de Hebra).

Regla Anatómica (Clave Diagnóstica)



ATACA:
Pubis, muslos,
glúteos.

RESPETA:
Escroto y pene
(inmunidad local
característica).

Alerta Diagnóstica: Diferenciar de **Eritrasma** (*C. minutissimum*). Usar **Luz de Wood** para confirmar.

Tiña de las Manos (Tinea Manuum)

Agente Principal: *Trichophyton rubrum*. Afecta más a hombres adultos.

Presentación Palmar



Hiperqueratosis y resequedad masiva.
Acentuación severa de los surcos palmares.
Presencia de vesículas o pústulas profundas.

Presentación Dorsal



Morfología anular (similar a Tinea Corporis).
Bordes eritematosos activos que se extienden
hacia zonas interdigitales.

Tiña de los Pies (Tinea Pedis / Pie de Atleta)

Contexto: Factores: Hiperhidrosis, baños públicos, calzado oclusivo/acolchado.

Vesículo-Ampollosa (Aguda)



Dorso y planta. Vesículas altamente pruriginosas. Alto riesgo de sobreinfección bacteriana por rascado.

Macerada Interdigital (Crónica)



Principalmente entre 4º y 5º dedo. Apariencia sancochada y blanquecina. Fisuras y grietas dolorosas.

Hiperqueratósica (Crónica)



Región plantar, talones y zonas laterales. Engrosamiento acartonado.

Complicaciones Inflammatorias y Tiña de la Barba

Complicaciones de Tinea Pedis

Tinea Pedis

Impétigo: Infección bacteriana secundaria por rascado (exudado amarillento).

Erisipela: Placa roja, brillante y circunscrita (simula celulitis).

Fenómeno IDE (Dermatofítide): Reacción de hipersensibilidad a distancia (Ej. vesículas disidróticas estériles en las manos).

Tiña de la Barba (Sicosis de la barba)



Agente/Epidemiología: *T. mentagrophytes*.
Hombres adultos (asociación laboral en granjas).

Clínica: Foliculitis pustulosa severa.
Formación de nódulos purulentos (Querión de la barba). Exudación melicérica.
Dolor extremo al tacto.

Tiña de las Uñas (Onicomycosis) y el Protocolo Clínico

Clínica Base: *T. rubrum*. Crónica. Detritus subungueal, engrosamiento, despegamiento de la lámina ungueal. Afecta principalmente el borde libre del primer dedo.

EL PROTOCOLO OBLIGATORIO

Paso 1: Toma de Muestra

🔪 Raspar placa ungueal por encima y por debajo.

Paso 2: Análisis

🔬 Directo (KOH) inmediato + Cultivo (espera de 30-40 días).

Paso 3: Identificación

🧪 Diferenciar Dermatófito vs. Moho vs. Levadura (Cándida).

Paso 4: Terapéutica Dirigida

💊 Elegir fármaco letal específico.
Advertencia: El tratamiento dura meses (riesgo de daño hepático);
NUNCA tratar a ciegas sin cultivo.

La Trampa Clínica: Tiña Incógnito

Definición: Modificación morfológica aberrante de una dermatofitosis inducida por el error médico de aplicar glucocorticoides tópicos.

Error Pathway



Manifestación Clínica

- Pérdida del borde activo típico.
- Lesiones rojo intenso o violáceas.
- Pústulas foliculares exageradas.

Resolución

Suspender corticoide ➡ Re-diagnosticar
➡ Antimicótico específico.

El Arsenal Diagnóstico (Pruebas Auxiliares)



1. Examen Micológico Directo (KOH 10-40%)

Hallazgo: Raspado + Hidróxido de Potasio. Confirma la presencia visual de estructuras fúngicas inmediatamente.

Tiempo: < 1 minuto.



2. Cultivos (Agar Sabouraud / Mycosel)

Hallazgo: Mycosel contiene antibióticos. Permite identificar la especie exacta del patógeno para terapia dirigida.

Tiempo: 25 a 40 días.



3. Luz de Wood (Lámpara UV)

Hallazgo: Tiñas microspóricas brillan verde-amarillento. Útil para diferenciar Tinea Cruris del Eritrasma.

Tiempo: Inmediato.

Matriz de Terapéutica Tópica (Coadyuvante o Limitada)

Indicaciones: Lesiones pequeñas, escasas. Onicomycosis (SOLO si afecta la parte distal/superficial).

REGLA DE ORO

**Duración mínima de 3 a 4 semanas.
Suspender el tratamiento al desaparecer
visualmente los síntomas garantiza la recaída.**

BADBEAR.MED

Fármacos Clave	Queratolíticos (Para costras/escamas gruesas)	Champús (Coadyuvante cabeza/barba)
• Imidazoles: Bifonazol, Clotrimazol, Ketoconazol, Sertaconazol (2 veces/día x 4-6 sem). • Otros: Tolnaftato 1%, Terbinafina, Ciclopiroxolamina 8% (lacas para uñas).	• Ácido salicílico (Aceite 2%, Gel 1.5%) • Fórmula 5 (Solución de Whitfield).	• Piritionato de zinc 2% • Ketoconazol 2-5% • Sulfuro de selenio 1.5-2.5%.

Matriz de Terapéutica Sistémica (El Tratamiento Definitivo)

Indicaciones: Lesiones extensas, fracaso tópico, Tinea Capitis, Tinea Barbae, Onicomycosis severa.

Terbinafina (El Estándar de Oro)	250mg adultos (5-10 mg/kg niños). Eficacia del 90% contra dermatofitos. (Uñas: 3 a 6 meses).
Itraconazol (Pulsoterapia)	Adultos. Diario (100-200mg/día x 3 meses) o Pulso (400mg/día x 1 semana, descanso 3 semanas; repetir 2-4 ciclos).
Griseofulvina (Elección en Niños)	10 mg/kg/día. Excelente en Tinea Capitis (8-12 semanas). Poca tolerancia gastrointestinal en adultos.
Fluconazol (Para Levaduras)	150mg/semana x 6-8 meses. Excelente para Cándida, pero baja eficacia (30%) contra dermatofitos.

Síntesis Clínica: Mapeo de Diagnóstico Diferencial

Cabeza: Dermatitis seborreica, Psoriasis, Alopecia areata/sifilítica, Tricotilomanía, Foliculitis bacteriana.

Barba: Folliculitis por S. aureus, Ántrax, Acné vulgar, Rosácea, Pseudofolliculitis.

Ingles: Eritrasma (luz de Wood), Intertrigo por Cándida, Psoriasis inversa.

Cuerpo (Tórax/Extremidades):
Pitiriasis rosada de Gibert,
Eccema numular,
Granuloma anular, Lepra
tuberculoide (Hansen),
Sífilis secundaria.

Manos/Pies: Dermatitis de contacto, Disidrosis, Queratólisis punteada, Queratodermia, Candidiasis intertriginosa.

